

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — ALTO RIESGO

Centro Materno-Infantil (sintético) — Hospitalización Obstétrica de Alto Riesgo

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	41 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Ama de casa
Fecha de ingreso:	20/04/2026

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Hipertensión arterial crónica diagnosticada hace 5 años, en tratamiento con metildopa 250 mg c/8 h desde inicio del embarazo (previamente recibía losartán, suspendido al confirmarse gestación). Diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 3 años, controlada con dieta y metformina 850 mg c/12 h continuada en gestación. Sobrepeso pregestacional (IMC 28).

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G5 P4 (4 hijos vivos — 2 partos vaginales 2010 y 2013, 2 cesáreas segmentarias 2017 y 2020, esta última por cesárea anterior + macrosomía). Sin antecedente de preeclampsia ni diabetes gestacional. Lactancia previa exitosa.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	10/08/2025
FPP:	17/05/2026
EG actual (por FUM):	36 semanas
Motivo de ingreso:	Vigilancia materno-fetal por riesgo múltiple
Controles prenatales:	9 al momento

Paciente refiere cefalea leve intermitente en últimas 72 horas que cede con reposo. Niega visión borrosa, epigastralgia o edema súbito. Movimientos fetales presentes. Adherencia al tratamiento antihipertensivo y antidiabético verificada.

EXAMEN FÍSICO AL INGRESO

PA 145/92 mmHg (confirmada en 2 tomas — límite alta, requiere ajuste). FC 86 lpm. T° 36.7°C. Peso 84.0 kg. Talla 1.58 m. IMC actual 33.6. Edema MMII (+/-) leve hasta tobillos. AU 33 cm. LCF 144 lpm. Sin signos clínicos de preeclampsia severa.

LABORATORIOS (20/04/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.5	g/dL	Límitrofe
Plaquetas	215000	/mm³	Normal
Creatinina	0.8	mg/dL	Normal
Urea	26	mg/dL	Normal
Glucosa basal	110	mg/dL	Sobre meta gestacional
HbA1c	6.2	%	Sobre meta (<6.0)
Proteinuria 24 h	0.4	g/24 h	No significativa
AST (TGO)	28	U/L	Normal
ALT (TGP)	32	U/L	Normal

LDH	280	U/L	Normal
-----	-----	-----	--------

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA (20/04/2026)

Feto único, vivo, presentación cefálica. Peso fetal estimado 3,150 g (percentil 88 — macrosomía límite). ILA 18 cm (límite alto). Placenta anterior grado II-III. Doppler arterias uterinas y umbilical normales. Doppler de arteria cerebral media normal.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

1. Embarazo de 36 semanas por FUM. 2. Hipertensión arterial crónica con control límite — descartar superposición de preeclampsia. 3. Diabetes mellitus tipo 2 pregestacional con control glucémico subóptimo (HbA1c 6.2%). 4. Macrosomía fetal límite (PFE percentil 88). 5. Edad materna avanzada + cesárea anterior x2 + gran múltipara. 6. Obesidad (IMC pregestacional 28, actual 33.6).

PLAN

1. Hospitalización en unidad de alto riesgo obstétrico para vigilancia. 2. Ajuste de antihipertensivos: agregar nifedipino retard 10 mg c/12 h. 3. Optimización de control glucémico: considerar agregar insulina basal nocturna. 4. NST cada 12 horas. Doppler fetal cada 48 horas. 5. Maduración pulmonar fetal si se decidiera cesárea antes de 37 semanas. 6. Programar cesárea segmentaria a las 38-39 semanas por antecedente de cesárea anterior x2 + macrosomía estimada + paridad alta. 7. Profilaxis tromboembólica con HBPM por factores de riesgo combinados. 8. Interconsulta con cardiología, endocrinología y anestesiología.

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.